

TEMA 3.52 • OBSTETRICIA

Patología Mamaria en el Puerperio

PERFIL EUNACOM 1.03.52
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Patología Mamaria en el Puerperio

EUNACOM CRITERIOS

Regla general: Ninguna complicación mamaria contraindica la lactancia materna. Todas incluyen mejorar la técnica de lactancia como parte del tratamiento.

Congestión Mamaria

Causa: mala técnica → acumulación de leche.

Clínica: dolor + congestión — **sin** fiebre ni eritema cutáneo.

- Tratamiento:**
- Mejorar técnica de lactancia
 - Vaciar mamas (manual o con extractor)
 - Analgesia (paracetamol)

Mastitis Puerperal

Causa: mala técnica → congestión → sobreinfección por gram(+): *S. aureus* (más frecuente), *Streptococcus* spp.

Clínica: dolor + congestión + **fiebre** + **eritema cutáneo** de la mama.

Diagnóstico: clínico.

Tratamiento:

TABLA 3.52.1: GRAVEDAD VS VÍA		
GRAVEDAD	VÍA	ANTIBIÓTICO
Leve	Oral	Cloxacilina / flucloxacilina / cefalosporinas / amoxicilina-clavulánico
Grave (choque, gran compromiso)	EV	Vancomicina + cefepime (cobertura SAMR + gram negativos)
Alergia a penicilina	Oral	Clindamicina

NOTA CLÍNICA

La madre puede y debe seguir amamantando — el bebé puede recibir esta leche.

Si no responde: → primero hacer **ecografía mamaria** para descartar **absceso** (no cambiar ATB directamente). Si el absceso es descartado → cultivo de leche y ajuste ATB.

Absceso Mamario

Causa: mastitis no tratada → *S. aureus* el más frecuente.

- Clínica:**
- Zona **fluctuante** dolorosa en la mama
 - O mastitis que **no responde** al tratamiento

Diagnóstico: clínico + **ecografía mamaria** (guía el drenaje, descarta flemón).

Tratamiento:

TABLA 3.52.2: OPCIÓN VS INDICACIÓN	
OPCIÓN	INDICACIÓN
ATB (igual a mastitis)	Siempre
Drenaje por punción eco-guiada	Primera línea actual
Drenaje quirúrgico	Si no responde a punción O necrosis cutánea

Grietas del Pezón

Causa: mala técnica de lactancia.

Clínica: dolor + eritema + grietas visibles en el pezón.

Tratamiento: únicamente **mejorar técnica de lactancia**.

NOTA CLÍNICA

Las pomadas de lanolina o leche materna **no tienen evidencia**; la técnica correcta es lo que resuelve el cuadro.

Punto Blanco (Perla Láctea)

Causa: obstrucción del ducto de salida del pezón.

Clínica: dolor + congestión localizada + punto blanco visible en el pezón.

Tratamiento: mejorar técnica de lactancia → resuelve en ~48 horas en la mayoría. ± masaje suave. Evitar protectores de pezón y sostenes compresivos.

Glándula Mamaria Accesorio (Polimastia)

Causa: congénita. **Localización más frecuente:** axila.

Clínica: aumento de volumen (con o sin pezón) que duele durante la lactancia (sin ducto de salida).

Tratamiento: frío local + paracetamol + educar (remite espontáneamente). Cirugía solo por estética.

Pezones Invertidos / Planos

Causa: variante normal.

Manejo: técnica de lactancia adecuada + educación (es posible amamantar con apoyo).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si un pezón se invierte de manera nueva (antes era normal): sospechar **cáncer de mama**. No confundir con variante congénita.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Patología Mamaria en el Puerperio: Tratamiento: mejorar técnica de lactancia → resuelve en ~48 horas en la mayoría.... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Patología Mamaria en el Puerperio. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Congestión Mamaria
- Mastitis Puerperal
- Absceso Mamario
- Grietas del Pezón
- Punto Blanco (Perla Láctea)
- Glándula Mamaria Accesorio (Polimastia)
- Pezones Invertidos / Planos

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PATOLOGÍA MAMARIA EN EL PUERPERIO)**PREGUNTA 1**

En relación a Patología Mamaria en el Puerperio: Tratamiento: mejorar técnica de lactancia → resuelve en ~48 horas en la mayoría.... ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de Patología Mamaria en el Puerperio se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Patología Mamaria en el Puerperio debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Patología Mamaria en el Puerperio requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Patología Mamaria en el Puerperio es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Patología Mamaria en el Puerperio no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Patología Mamaria en el Puerperio?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Patología Mamaria en el Puerperio. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: PATOLOGÍA MAMARIA EN EL PUERPERIO

Tratamiento: 1. Mejorar técnica de lactancia 2. Vaciar mamas (manual o con extractor) 3. Analgesia (paracetamol) Causa: mala técnica → congestión → sobreinfección por gram(+): *S. aureus* (más frecuente), *Streptococcus* spp. Si no responde: → primero hacer ecografía mamaria para descartar absceso (no cambiar ATB directamente). Si el absceso es descartado → cultivo de leche y ajuste ATB.